INSTITUT DE PSYCHOLOGIE CENTRÉE SUR LE SENS

Revue de *psychologie centrée* sur le sens

Volume 1 · Numéro 2 · octobre 2026 · Édition française

Sens, valeurs et défis existentiels dans la pratique psychothérapeutique

Logothérapie · Psychologie existentielle · Recherche en psychothérapie

p. 18–33 · Libre accès

Sommaire

Numéro 2/2026 · Thème: Sens, valeurs et défis existentiels dans la pratique psychothérapeutique · pagination de la version originale anglaise

ÉDITORIAL

Valeurs, rencontre et limites du faisable 18

Sur le thème du deuxième numéro

Eleanor M. Whitcombe, Sora Pazer et Samuel R. Ashford

ARTICLE THÉORIQUE

Les valeurs dans la thérapie d'acceptation et d'engagement et les catégories de valeurs de Frankl 20

Convergences et différences entre deux conceptions des valeurs

Eleanor M. Whitcombe, Samuel R. Ashford et Sora Pazer

ARTICLE DE SYNTHÈSE

La psychothérapie centrée sur le sens en soins palliatifs 23

Conception, état des données probantes et questions de transférabilité

Samuel R. Ashford, Sora Pazer et Eleanor M. Whitcombe

PRATIQUE ET ENSEIGNEMENT

Le conseil d'orientation logothérapeutique en cas d'épuisement professionnel et de crises de sens 27

Grandes lignes, démarche et limites – avec une vignette pédagogique construite

Eleanor M. Whitcombe, Sora Pazer et Samuel R. Ashford

COMPTE RENDU

Un psychologue fait l'expérience du camp de concentration 31

**… trotzdem Ja zum Leben sagen* ou *Man's Search for Meaning* de Viktor E. Frankl – une relecture dans une perspective contemporaine*

Samuel R. Ashford, Eleanor M. Whitcombe et Sora Pazer

Éditeur
Institut de psychologie centrée sur le sens

Périodicité
Semestrielle, en avril et en octobre, ainsi que des numéros spéciaux

Évaluation
Examen éditorial et évaluation en double aveugle

Licence et utilisation de l'IA
Tous les articles sont publiés en libre accès sous licence CC BY 4.0. Ils ont été rédigés avec l'aide de l'IA générative et relus par les auteurs. La langue originale est l'anglais ; l'édition française est une traduction.

Revue de psychologie centrée sur le sens
PUBLIÉE PAR L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE CENTRÉE SUR LE SENS

Volume 1 · Numéro 2 · octobre 2026
p. 18–19 (Original) · Libre accès · CC BY 4.0

ÉDITORIAL

Valeurs, rencontre et limites du faisable

Sur le thème du deuxième numéro

Eleanor M. Whitcombe, Sora Pazer et Samuel R. Ashford
Institut de psychologie centrée sur le sens

Traduction française. La version originale anglaise fait foi.

RÉSUMÉ

Le deuxième numéro du premier volume de la Zeitschrift für Sinnzentrierte Psychologie déplace son attention des questions méthodologiques du premier numéro vers la pratique thérapeutique et le conseil. Sous le thème « Sens, valeurs et défis existentiels dans la pratique psychothérapeutique », il réunit des articles qui mettent en relation des concepts centraux de la logothérapie avec des traitements et des contextes de soins contemporains. Un article théorique compare le concept de valeurs de la thérapie d'acceptation et d'engagement avec les catégories de valeurs de Viktor E. Frankl. Une revue de la littérature décrit la psychothérapie centrée sur le sens en soins palliatifs et en évalue la base de données probantes. Une contribution issue de la pratique et de l'enseignement expose les principes d'un conseil d'inspiration logothérapeutique en cas d'épuisement professionnel (burnout) et de crises de sens. Un compte rendu d'ouvrage réexamine dans une perspective contemporaine le récit de Frankl « Man's Search for Meaning ». L'éditorial esquisse le point de référence commun de ces articles : la question de savoir comment la psychothérapie peut composer avec ce qui ne peut être changé, et quel rôle les valeurs et le sens jouent à cet égard. Il rappelle également les principes éditoriaux de la revue, en particulier le signalement clair des vignettes de cas didactiques comme exemples pédagogiques construits.

Mots-clés : valeurs · logothérapie · pratique psychothérapeutique · soins palliatifs · éditorial

ABSTRACT

The second issue of the first volume of the Journal of Meaning-Centered Psychology shifts its focus from the methodological questions of the first issue toward therapeutic and counseling practice. Under the theme "Meaning, values, and existential challenges in psychotherapeutic practice," it brings together papers that relate central concepts of logotherapy to contemporary treatments and settings of care. A theoretical paper compares the concept of values in acceptance and commitment therapy with Viktor E. Frankl's categories of values. A review describes meaning-centered psychotherapy in palliative care and appraises its evidence base. A contribution on practice and teaching outlines principles of logotherapeutically informed counseling for burnout and crises of meaning. A book review reassesses Frankl's account "Man's Search for Meaning" from a contemporary perspective. The editorial sketches the common point of reference of these papers: the question of how psychotherapy can deal with what cannot be changed, and which role values and meaning play in this respect. It also recalls the journal's editorial principles, in particular the clear labeling of didactic case vignettes as constructed teaching examples.

Keywords: values · logotherapy · psychotherapeutic practice · palliative care · editorial

De l'état de la recherche à la pratique

Le premier numéro de cette revue était consacré à la question de savoir comment situer la logothérapie dans le contexte de la recherche contemporaine en psychothérapie. Le présent deuxième numéro se tourne davantage vers la pratique thérapeutique et le conseil. Son thème est « Sens, valeurs et défis existentiels dans la pratique psychothérapeutique ». Ce changement de perspective ne signifie pas un renoncement à l'exigence de rigueur scientifique ; il répond plutôt au constat que l'imprécision conceptuelle peut avoir des conséquences particulièrement lourdes dans la pratique.

Un motif fédérateur des contributions est la question de savoir comment la psychothérapie peut composer avec ce qui ne peut être changé. Outre les valeurs créatrices et les valeurs d'expérience, Frankl (1946) a décrit les valeurs d'attitude, qui se réalisent dans l'attitude d'une personne face à une souffrance

inéluctable. Yalom (1980) a désigné la mort, la liberté, l'isolement et l'absence de sens comme les préoccupations ultimes de l'existence, auxquelles toute psychothérapie doit tôt ou tard se confronter.

Pour la pratique psychothérapeutique, cette question revêt une importance immédiate. De nombreuses approches thérapeutiques visent à produire un changement : les symptômes doivent diminuer, les schémas dysfonctionnels se dissoudre, les capacités croître. Pourtant, tout ce qui pèse sur les personnes ne peut être changé. Les maladies chroniques et limitant l'espérance de vie, les pertes, les décisions de vie irréversibles ou les conditions structurelles du monde du travail fixent des limites à ce qui peut être atteint sur le plan thérapeutique. C'est précisément à ces limites que la question du sens et des valeurs prend du poids.

Les contributions de ce numéro

Le département Thérapie cognitivo-comportementale et approches contextuelles compare le concept de valeurs de la thérapie d'acceptation et d'engagement (Hayes et al., 2012) avec les catégories de valeurs de Frankl et se demande où existent de véritables convergences et où il n'y a que de simples ressemblances de famille. Le département Psycho-oncologie et psychologie palliative présente une revue de la littérature consacrée à la psychothérapie centrée sur le sens (Meaning-Centered Psychotherapy), qui compte parmi les interventions centrées sur le sens les plus soigneusement étudiées (Breitbart et al., 2015).

La contribution issue de la pratique et de l'enseignement du département Psychologie du conseil développe les grandes lignes d'un conseil d'orientation logothérapeutique en cas d'épuisement professionnel et de crises de sens. Elle travaille avec une vignette pédagogique explicitement signalée comme construite et distingue soigneusement le conseil du traitement des troubles mentaux. Le numéro se clôt par un compte rendu du récit de Frankl *... trotzdem Ja zum Leben sagen* (Man's Search for Meaning), qui s'interroge sur la portée durable, mais aussi sur les limites, de ce livre largement lu.

Les contributions montrent de différentes manières que se confronter à ces limites ne signifie pas nécessairement se résigner. Cela exige toutefois une attitude qui ni n'offre prématurément de consolation, ni ne glorifie la souffrance comme moyen de trouver du sens. Frankl lui-même a souligné que la souffrance évitable doit être supprimée et que seule la souffrance inévitable offre une occasion de réaliser des valeurs d'attitude (Frankl, 1946).

Perspectives

Avec ce numéro s'achève le premier volume de la revue. La rédaction remercie les départements participants pour leurs contributions et pour leur disposition à s'engager envers les principes d'intégrité de la revue : présentation prudente des résultats empiriques, signalement transparent des prémisses théoriques et des exemples de cas construits, et orientation constante vers des sources vérifiables. Nous nous réjouissons de poursuivre la discussion dans le prochain volume.

Références

Breitbart, W., Rosenfeld, B., Pessin, H., Applebaum, A., Kulikowski, J., & Lichtenthal, W. G. (2015). Meaning-centered group psychotherapy: An effective intervention for improving psychological well-being in patients with advanced cancer. Journal of Clinical Oncology, 33(7), 749–754.

Frankl, V. E. (1946). Ärztliche Seelsorge. Deuticke.

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2012). Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change (2nd ed.). Guilford Press.

Yalom, I. D. (1980). Existential psychotherapy. Basic Books.

CITATION (VERSION ORIGINALE)

Whitcombe, E. M., Pazer, S., & Ashford, S. R. (2026). Values, Encounter, and the Limits of What Can Be Done: On the Focus of the Second Issue. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(2), 18–19.

LICENCE, CORRESPONDANCE ET UTILISATION DE L'IA

Publié en libre accès sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Correspondance : rédaction de la revue. Cet article a été rédigé avec l'aide de l'IA générative et relu par les auteurs, qui en assument l'entière responsabilité.

Revue de psychologie centrée sur le sens
PUBLIÉE PAR L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE CENTRÉE SUR LE SENS

Volume 1 · Numéro 2 · octobre 2026
p. 20–22 (Original) · Libre accès · CC BY 4.0

ARTICLE THÉORIQUE

Les valeurs dans la thérapie d'acceptation et d'engagement et les catégories de valeurs de Frankl

Convergences et différences entre deux conceptions des valeurs

Eleanor M. Whitcombe, Samuel R. Ashford et Sora Pazer
Institut de psychologie centrée sur le sens

Traduction française. La version originale anglaise fait foi.

RÉSUMÉ

Les valeurs occupent une position centrale aussi bien dans la thérapie d'acceptation et d'engagement (ACT) que dans la logothérapie. Dans l'ACT, les valeurs sont comprises comme des qualités de l'action en cours, librement choisies et construites verbalement, qui guident le comportement engagé et donnent une direction à la flexibilité psychologique. Viktor E. Frankl, en revanche, distinguait des valeurs créatrices, des valeurs d'expérience et des valeurs d'attitude, qui selon lui ne sont pas inventées, mais découvertes dans chaque situation. Cet article théorique compare systématiquement les deux conceptions. Il identifie des convergences, telles que la distinction entre valeurs et objectifs, l'accent mis sur l'action et l'engagement, l'importance des valeurs face à une souffrance inévitable et la fonction des valeurs comme contrepoids à une thérapie exclusivement orientée vers les symptômes. Il met en même temps en évidence des différences fondamentales, qui découlent d'arrière-plans philosophiques distincts : le contextualisme fonctionnel de l'ACT d'une part, l'anthropologie phénoménologique et personnaliste de Frankl d'autre part. Une attention particulière est accordée à la question de savoir si les valeurs sont choisies ou découvertes, ainsi qu'au statut des valeurs d'attitude. L'article se conclut par des réflexions sur la manière dont les deux traditions peuvent apprendre l'une de l'autre sans brouiller leurs prémisses respectives.

Mots-clés : thérapie d'acceptation et d'engagement · valeurs · logothérapie · valeurs d'attitude · flexibilité psychologique

ABSTRACT

Values occupy a central position in both acceptance and commitment therapy (ACT) and logotherapy. In ACT, values are understood as freely chosen, verbally constructed qualities of ongoing action that guide committed behavior and give direction to psychological flexibility. Viktor E. Frankl, in contrast, distinguished creative, experiential, and attitudinal values, which, in his view, are not invented but discovered in the respective situation. This theoretical paper systematically compares the two conceptions. It identifies convergences, such as the distinction between values and goals, the emphasis on action and engagement, the significance of values in dealing with unavoidable suffering, and the function of values as a counterweight to an exclusively symptom-oriented therapy. At the same time, it highlights fundamental differences that arise from distinct philosophical backgrounds: the functional contextualism of ACT on the one hand and Frankl's phenomenological and personalist anthropology on the other. Particular attention is paid to the question of whether values are chosen or discovered and to the status of attitudinal values. The paper concludes with reflections on how both traditions can learn from each other without blurring their respective premises.

Keywords: acceptance and commitment therapy · values · logotherapy · attitudinal values · psychological flexibility

1 Introduction

Dans la psychothérapie des dernières décennies, le concept de valeurs a connu une renaissance remarquable. La thérapie d'acceptation et d'engagement (ACT), qui fait des valeurs l'un de ses six processus centraux, y a largement contribué (Hayes et al., 1999, 2012). Pour les lecteurs familiers de la logothérapie, cette évolution présente un intérêt particulier, car Frankl avait déjà développé, des décennies plus tôt, une théorie des valeurs qui se trouve au centre de son approche psychothérapeutique (Frankl, 1946).

L'hypothèse, qui vient spontanément à l'esprit, selon laquelle il s'agirait de deux variantes d'une même idée fondamentale reste toutefois insuffisante. Les deux traditions sont nées dans des contextes

épistémologiques et anthropologiques différents, et les mêmes termes y revêtent parfois des significations différentes. La présente contribution compare les deux conceptions afin de nommer précisément les points communs et d'éviter un nivellement prématuré des différences.

La comparaison procède en quatre étapes. Le concept de valeurs de l'ACT est d'abord situé dans son contexte théorique, puis la théorie des valeurs de Frankl est esquissée. Sur cette base, les convergences et les différences sont dégagées. Enfin, les implications pour la pratique, l'évaluation et la recherche sont discutées. La contribution se limite au niveau conceptuel et ne se prononce pas sur l'efficacité comparée des deux approches.

2 Les valeurs dans la thérapie d'acceptation et d'engagement

L'ACT se conçoit comme une application du contextualisme fonctionnel et de la théorie des cadres relationnels, une approche issue de l'analyse du comportement visant à expliquer le langage et la cognition humains (Hayes et al., 2001). Selon cette conception, la souffrance psychique naît essentiellement de l'inflexibilité psychologique, c'est-à-dire de la domination de règles verbales rigides, de stratégies d'évitement expérientiel et d'un rétrécissement du répertoire comportemental (Hayes et al., 2006). La flexibilité psychologique, à l'inverse, est considérée comme un aspect fondamental de la santé mentale (Kashdan & Rottenberg, 2010).

Dans l'ACT, les valeurs sont décrites comme des conséquences librement choisies et construites verbalement de schémas d'activité continus et évolutifs, qui fonctionnent comme des renforçateurs et donnent une direction à l'action (Hayes et al., 2012). La distinction entre valeurs et objectifs est essentielle : les objectifs peuvent être atteints et menés à terme, alors que les valeurs ressemblent à une direction de boussole sur laquelle on s'oriente sans jamais arriver. Les valeurs ne doivent en outre pas découler du devoir, de la pression sociale ou du désir d'éviter la douleur, mais être vécues comme personnellement significatives. Des instruments spécifiques ont été développés pour évaluer l'action guidée par les valeurs, tels que le Valued Living Questionnaire (Wilson et al., 2010).

Dans le travail thérapeutique en ACT, les valeurs sont souvent explorées au moyen d'exercices expérientiels, par exemple en imaginant ses propres funérailles ou en se demandant ce que l'on veut incarner dans la vie (Hayes et al., 1999). La clarification des valeurs n'est pas un acte ponctuel, mais un processus continu étroitement lié à l'action engagée. On veille en même temps à ne pas ériger les valeurs en nouvelles règles rigides, qui pourraient à leur tour conduire à l'inflexibilité.

3 Les catégories de valeurs de Frankl

Frankl distinguait trois voies principales par lesquelles les personnes peuvent réaliser du sens (Frankl, 1946, 1955). Les valeurs créatrices se réalisent dans ce qu'une personne donne au monde, par exemple par le travail ou la création. Les valeurs d'expérience se réalisent dans ce qu'une personne reçoit du monde, par exemple dans la rencontre avec la nature, l'art ou un autre être humain. Les valeurs d'attitude, enfin, se réalisent dans l'attitude qu'une personne adopte face à un destin inéluctable, en particulier face à une souffrance inévitable.

Pour Frankl, le sens et les valeurs ne sont pas inventés, mais trouvés. Selon sa conception, le sens se rapporte toujours à une situation concrète et s'adresse comme un appel à la personne singulière, qui y répond de manière responsable (Frankl, 1969). La conscience fonctionne ici comme « organe du sens », capable de pressentir le sens unique d'une situation. Cette conception s'inscrit dans une anthropologie qui postule une dimension spirituelle de l'être humain et considère l'autotranscendance – l'orientation vers quelque chose ou quelqu'un au-delà de soi-même – comme la marque distinctive de l'existence humaine.

Les catégories de valeurs de Frankl ne doivent pas être comprises au sens d'une hiérarchie rigide ; il attribuait néanmoins une dignité particulière aux valeurs d'attitude, parce qu'elles peuvent encore être réalisées là où les possibilités créatrices et d'expérience sont épuisées. C'est là que réside la pointe de sa thèse du caractère inconditionnellement sensé de la vie : tant qu'une personne vit, il lui reste au moins la possibilité de prendre position face à son destin (Frankl, 1946).

4 Convergences

Malgré leurs origines différentes, plusieurs convergences peuvent être identifiées. Premièrement, les deux approches soulignent la distinction entre une direction englobante et des objectifs concrets. La manière dont Frankl parle du sens comme d'une tâche qui se pose à nouveau dans chaque situation et la métaphore de la direction de boussole de l'ACT indiquent toutes deux que les valeurs ne peuvent être cochées sur une liste. Deuxièmement, les deux traditions mettent l'accent sur l'action et l'engagement

plutôt que sur la simple prise de conscience. Troisièmement, toutes deux voient dans les valeurs un contrepoids à une thérapie orientée exclusivement vers la réduction des symptômes.

Le plus frappant est leur proximité dans la manière d'aborder la souffrance inévitable. L'ACT invite les personnes à ne pas combattre les expériences intérieures douloureuses, mais à les accepter au service d'une action guidée par les valeurs. Les valeurs d'attitude de Frankl visent une attitude apparentée : là où une situation ne peut être changée, demeure la liberté de prendre position à son égard. Dans les deux cas, faire face à la souffrance est compris non comme sa suppression, mais comme une transformation de son rapport à elle.

5 Différences

La différence la plus fondamentale concerne le statut des valeurs. Dans l'ACT, les valeurs sont choisies ; leur signification résulte de leur fonction pour l'action d'une personne, et le contextualisme fonctionnel s'abstient délibérément de tout énoncé ontologique sur la question de savoir si les valeurs existent indépendamment des êtres humains (Hayes, 2004). Pour Frankl, en revanche, les valeurs et le sens ne peuvent être choisis arbitrairement, mais possèdent un caractère d'exigence qui s'impose à la personne de l'extérieur. Cette différence n'est pas seulement terminologique : elle a des conséquences pour la question de savoir si un thérapeute peut interroger les valeurs d'un client, ainsi que pour la signification de la responsabilité et de la conscience.

Une deuxième différence concerne les valeurs d'attitude. Dans l'ACT, l'acceptation est un processus qui rend possible l'action guidée par les valeurs, mais qui n'est pas elle-même une valeur. Pour Frankl, en revanche, l'attitude face à la souffrance peut elle-même être porteuse de sens – même lorsqu'il n'existe plus d'autres possibilités d'action. Cette position prend un poids particulier dans les situations où la marge d'action est fortement limitée, par exemple en cas de maladie grave en fin de vie.

Une troisième différence concerne le rôle de l'autotranscendance. Avec le soi comme contexte, l'ACT dispose d'une perspective qui conduit au-delà de l'identification aux concepts de soi. L'autotranscendance de Frankl désigne toutefois autre chose : le fait de se tourner vers un sens ou vers une autre personne au-delà de son propre vécu. L'analyse existentielle a elle aussi souligné la prise de position personnelle comme une dimension autonome (Längle, 2013).

Une quatrième différence concerne la relation entre langage et sens. Dans l'ACT, le langage est considéré comme une arme à double tranchant : la capacité à former des cadres relationnels rend possibles les valeurs et l'orientation vers l'avenir, mais elle est en même temps une source de rumination, d'auto-évaluation et d'évitement expérientiel (Hayes et al., 2001). Frankl, en revanche, considère la dimension spirituelle non pas d'abord sous l'angle de ses risques, mais comme source de liberté et de responsabilité. Le scepticisme de l'ACT à l'égard de la domination des règles verbales n'a pas d'équivalent direct en logothérapie, même si la critique franklienne de l'hyperréflexion va dans une direction apparentée.

6 Conclusions

La comparaison montre que l'ACT et la logothérapie sont étonnamment proches dans leur orientation pratique, mais divergent nettement dans leurs fondements philosophiques. Pour la pratique, cela peut être enrichissant : l'ACT offre une multitude d'exercices éprouvés pour clarifier les valeurs et favoriser la flexibilité psychologique ; la logothérapie offre un langage différencié pour aborder la souffrance inéluctable et la question de savoir vers quoi une personne s'oriente au-delà d'elle-même. Pour la recherche se pose la tâche d'opérationnaliser les différences entre les conceptions des valeurs de telle sorte que leurs contributions respectives au changement deviennent empiriquement distinguables. Un mélange éclectique sans réflexion sur les prémisses ne servirait en revanche aucune des deux traditions.

Il en découle des exigences différentes pour la mesure. Les instruments issus de la tradition de l'ACT évaluent typiquement l'importance que revêtent certains domaines de vie pour une personne et la cohérence avec laquelle elle agit en conformité avec eux (Wilson et al., 2010). Des concepts logothérapeutiques tels que la réalisation des valeurs d'attitude ne peuvent être représentés que de manière insuffisante par de tels instruments, puisqu'ils concernent précisément les situations dans lesquelles une action conforme aux valeurs au sens habituel n'est guère possible. Il existe ici un besoin de développement en matière d'évaluation.

Références

Frankl, V. E. (1946). Ärztliche Seelsorge. Deuticke.

Frankl, V. E. (1955). The doctor and the soul: An introduction to logotherapy. Knopf.

Frankl, V. E. (1969). The will to meaning: Foundations and applications of logotherapy. New American Library.

Hayes, S. C. (2004). Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the third wave of behavioral and cognitive therapies. Behavior Therapy, 35(4), 639–665.

Hayes, S. C., Barnes-Holmes, D., & Roche, B. (Eds.). (2001). Relational frame theory: A post-Skinnerian account of human language and cognition. Kluwer Academic/Plenum Publishers.

Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour Research and Therapy, 44(1), 1–25.

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (1999). Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behavior change. Guilford Press.

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2012). Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change (2nd ed.). Guilford Press.

Kashdan, T. B., & Rottenberg, J. (2010). Psychological flexibility as a fundamental aspect of health. Clinical Psychology Review, 30(7), 865–878.

Längle, A. (2013). Lehrbuch zur Existenzanalyse: Grundlagen. facultas.wuv.

Wilson, K. G., Sandoz, E. K., Kitchens, J., & Roberts, M. (2010). The Valued Living Questionnaire: Defining and measuring valued action within a behavioral framework. The Psychological Record, 60(2), 249–272.

CITATION (VERSION ORIGINALE)

Whitcombe, E. M., Ashford, S. R., & Pazer, S. (2026). Values in Acceptance and Commitment Therapy and Frankl's Categories of Values: Convergences and Differences Between Two Conceptions of Values. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(2), 20–22.

LICENCE, CORRESPONDANCE ET UTILISATION DE L'IA

Publié en libre accès sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Correspondance : rédaction de la revue. Cet article a été rédigé avec l'aide de l'IA générative et relu par les auteurs, qui en assument l'entière responsabilité.

Revue de psychologie centrée sur le sens
PUBLIÉE PAR L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE CENTRÉE SUR LE SENS

Volume 1 · Numéro 2 · octobre 2026
p. 23–26 (Original) · Libre accès · CC BY 4.0

ARTICLE DE SYNTHÈSE

La psychothérapie centrée sur le sens en soins palliatifs

Conception, état des données probantes et questions de transférabilité

Samuel R. Ashford, Sora Pazer et Eleanor M. Whitcombe
Institut de psychologie centrée sur le sens

Traduction française. La version originale anglaise fait foi.

RÉSUMÉ

Outre les symptômes physiques, les personnes atteintes de maladies avancées et incurables sont fréquemment confrontées à une détresse existentielle, telle que le désespoir, la perte de sens ou le désir de mort anticipée. La psychothérapie centrée sur le sens (Meaning-Centered Psychotherapy, MCP), développée par William Breitbart et ses collaborateurs, est une intervention manualisée qui s'appuie explicitement sur la logothérapie de Viktor E. Frankl et vise à aider les patients à éprouver du sens même face à une espérance de vie limitée. Cette revue narrative décrit d'abord les fondements théoriques et la structure de l'intervention dans ses formats de groupe et individuel. Elle résume ensuite les données issues d'essais contrôlés randomisés, qui indiquent dans l'ensemble des effets favorables sur le bien-être spirituel, le sentiment de sens et la qualité de vie. Les limites de la recherche existante sont discutées, en particulier la concentration sur des populations et des systèmes de santé spécifiques, la gestion des abandons dans une population gravement malade et les questions de transférabilité culturelle. Enfin, la MCP est comparée à d'autres interventions d'orientation existentielle en soins palliatifs, telles que la thérapie de la dignité. L'article se conclut par des réflexions sur la mise en œuvre dans les pays germanophones et sur les qualifications requises des cliniciens.

Mots-clés : psychothérapie centrée sur le sens · soins palliatifs · psycho-oncologie · détresse existentielle · logothérapie

ABSTRACT

In addition to physical symptoms, people with advanced, incurable illnesses frequently face existential distress, such as hopelessness, loss of meaning, or a desire for hastened death. Meaning-centered psychotherapy (MCP), developed by William Breitbart and colleagues, is a manualized intervention that explicitly builds on Viktor E. Frankl's logotherapy and aims to help patients experience meaning even in the face of limited life expectancy. This narrative review first describes the theoretical foundations and the structure of the intervention in its group and individual formats. It then summarizes the evidence from randomized controlled trials, which overall points to favorable effects on spiritual well-being, sense of meaning, and quality of life. Limitations of the existing research are discussed, in particular the concentration on specific populations and health care systems, the handling of attrition in a severely ill population, and questions of cultural transferability. Finally, MCP is compared with other existentially oriented interventions in palliative care, such as dignity therapy. The paper concludes with considerations regarding implementation in German-speaking countries and the qualifications required of clinicians.

Keywords: meaning-centered psychotherapy · palliative care · psycho-oncology · existential distress · logotherapy

1 Introduction

Les soins palliatifs modernes se conçoivent comme un accompagnement global des personnes gravement malades, qui tient compte à parts égales des dimensions physique, psychologique, sociale et spirituelle de la souffrance. Les difficultés existentielles en fin de vie en particulier – l'expérience de l'absence de sens, le désespoir ou le désir de mort anticipée – posent des défis particuliers aux soignants, car elles ne peuvent trouver de réponse dans les seules mesures orientées vers les symptômes. Yalom (1980) a décrit la confrontation avec sa propre finitude comme une préoccupation ultime centrale de l'existence, qui devient inéluctable face à une maladie limitant l'espérance de vie.

C'est dans ce contexte que la psychothérapie centrée sur le sens (Meaning-Centered Psychotherapy, MCP) a été développée au Memorial Sloan Kettering Cancer Center de New York. Elle compte parmi les rares interventions centrées sur le sens à avoir été étudiées dans plusieurs essais contrôlés randomisés et constitue ainsi un point de référence important pour la discussion de la base de données probantes des procédures d'inspiration logothérapeutique. La présente contribution offre un aperçu narratif de sa conception et de l'état de la recherche et s'interroge sur sa transférabilité à d'autres contextes de soins.

Sur le plan conceptuel, la détresse existentielle peut être distinguée de la dépressivité, même si les deux peuvent se recouvrir. Le désespoir, la perte de sens ou le sentiment d'être un fardeau pour autrui peuvent survenir chez des personnes gravement malades même en l'absence du tableau complet d'un trouble dépressif. Il en résulte un besoin d'interventions qui prennent explicitement pour objet les thèmes existentiels.

2 Fondements théoriques

La MCP se réfère explicitement à l'œuvre de Viktor E. Frankl. Ses présupposés centraux sont que la quête de sens représente une motivation humaine fondamentale, que le sens peut être éprouvé même dans des conditions de souffrance grave et de temps de vie limité, et que les personnes conservent la liberté de choisir leur attitude face à des circonstances inéluctables (Frankl, 1946/2006). Breitbart et Poppito (2014) traduisent les catégories de valeurs de Frankl en sources de sens concrètes, explorées systématiquement au cours de l'intervention : des sources de sens historiques, au sens de l'héritage de sa propre vie ; des sources de sens d'attitude, dans la manière de faire face aux limites de la vie ; des sources de sens créatrices, au sens de la responsabilité et de l'engagement ; et des sources de sens d'expérience, dans l'amour, la beauté et l'humour.

En outre, la MCP peut être comprise dans le cadre du modèle d'élaboration de sens de Park (2010). Un diagnostic limitant l'espérance de vie peut créer un profond décalage entre les objectifs de vie globaux et la situation actuelle. La MCP peut être comprise comme un soutien structuré aux processus d'élaboration de sens, qui ne nient pas ce décalage, mais l'inscrivent dans un contexte de sens plus large.

Une autre idée fondamentale est la distinction entre ce qui ne peut être changé face à la maladie et ce qui reste ouvert à l'action. L'intervention invite les participants à percevoir les deux : reconnaître les limites sans perdre de vue les possibilités restantes. On y retrouve l'idée de Frankl selon laquelle le sens peut être réalisé non seulement dans l'action et dans l'expérience, mais aussi dans l'attitude face à l'inéluctable.

3 Structure de l'intervention

Le format de groupe, la Meaning-Centered Group Psychotherapy (MCGP), comprend huit séances hebdomadaires, chacune consacrée à un thème (Breitbart & Poppito, 2014). Les séances associent des éléments didactiques, dans lesquels sont transmis des concepts de la logothérapie, à des exercices expérientiels et à des discussions de groupe. Le programme commence par une exploration du concept de sens et de la question de savoir comment la maladie a modifié l'expérience du sens. Suivent des séances sur les différentes sources de sens, le travail sur son propre héritage jouant un rôle particulièrement important. Le programme se conclut par une réflexion sur le processus commun et un regard sur les espoirs pour le temps restant.

Pour les patients pour lesquels la participation à un groupe n'est pas possible, un format individuel, l'Individual Meaning-Centered Psychotherapy, a été développé ; il prévoit une séquence de séances plus courte et peut être adapté de manière plus souple à l'évolution de la maladie (Breitbart et al., 2012). La manualisation facilite la formation des praticiens et la réalisation d'études contrôlées, mais exige en même temps un haut degré de jugement clinique afin d'adapter la structure aux besoins individuels des personnes gravement malades.

Un élément caractéristique de l'intervention est le travail sur un projet d'héritage. Les participants sont invités à élaborer un projet qui exprime leur vie et leurs valeurs et qui renvoie au-delà de leur propre temps de vie – par exemple consigner des souvenirs, se réconcilier avec une personne proche ou mener un projet créatif. Cet élément relie les valeurs créatrices décrites par Frankl à la question de savoir ce qui reste d'une vie (Breitbart & Poppito, 2014).

4 État des données probantes

La première étude pilote randomisée a comparé la MCGP à une psychothérapie de groupe de soutien chez des patients atteints d'un cancer avancé (Breitbart et al., 2010). Les résultats ont indiqué des avantages de la condition centrée sur le sens en ce qui concerne le bien-être spirituel et le sens vécu ; il y avait en outre des indices d'une diminution du désespoir et du désir de mort. Une étude pilote du

format individuel a également montré des résultats favorables par rapport à une condition contrôle (Breitbart et al., 2012).

Un essai randomisé de plus grande taille, avec une psychothérapie de groupe de soutien active comme condition de comparaison, a pour l'essentiel confirmé cette orientation des résultats (Breitbart et al., 2015). Le groupe centré sur le sens a montré des avantages en ce qui concerne le bien-être spirituel et la qualité de vie, ainsi que des indices d'une réduction de la dépressivité, du désespoir et du désir de mort anticipée. Il est notable que les différences sont apparues par rapport à une condition contrôle active qui contenait elle-même des facteurs non spécifiques tels que la cohésion de groupe et le soutien émotionnel. Des interventions centrées sur le sens de ce type ont également été incluses dans la méta-analyse des thérapies existentielles de Vos et al. (2015) et ont contribué au tableau d'ensemble favorable des interventions structurées centrées sur le sens.

Dans le même temps, il faut garder à l'esprit les limites de ces résultats. Les études ont été menées principalement dans un centre d'oncologie spécialisé aux États-Unis. Dans une population gravement malade, les abandons d'étude dus à la progression de la maladie ou au décès sont inévitables, ce qui complique l'interprétation des données longitudinales. Enfin, la question de savoir dans quelle mesure les résultats peuvent être transposés à d'autres groupes diagnostiques, systèmes de santé et contextes culturels reste ouverte.

Un autre aspect concerne le choix des critères de résultat. Outre des mesures de symptômes, les études ont utilisé en particulier des instruments portant sur le bien-être spirituel et la qualité de vie. Ce choix correspond à l'objectif de l'intervention, mais doit être pris en compte dans les comparaisons avec d'autres procédures psychothérapeutiques visant principalement la réduction des symptômes. La question de savoir quelles composantes de l'intervention sont responsables des changements observés n'a pas non plus encore reçu de réponse définitive.

5 Délimitation par rapport aux interventions apparentées

Parmi les interventions d'orientation existentielle en soins palliatifs, la thérapie de la dignité (Dignity Therapy) est devenue particulièrement connue aux côtés de la MCP (Chochinov et al., 2005). Elle vise à renforcer le sentiment de dignité en fin de vie et travaille avec un entretien structuré dont résulte un document écrit pouvant être transmis aux proches. Les deux approches partagent l'accent mis sur l'héritage et la revue de vie. La MCP est toutefois conçue de manière plus psychoéducative, comprend plusieurs séances et poursuit l'objectif de renforcer l'expérience du sens également au regard du temps de vie restant, alors que la thérapie de la dignité est plus concise et orientée vers la création d'un document de générativité.

Les deux interventions ont en commun de comprendre les thèmes existentiels non comme un simple effet secondaire de troubles mentaux, mais comme un objet à part entière des soins palliatifs. Elles se distinguent en cela d'une approche purement psychopathologique, qui considère la détresse existentielle principalement du point de vue d'une dépression ou d'une anxiété comorbide. Dans la pratique, le choix entre les approches peut dépendre du temps de vie restant, des capacités physiques et des préférences des patients.

6 Implications pour les soins dans les pays germanophones

Plusieurs questions se posent pour la mise en œuvre dans les pays germanophones. Premièrement, une adaptation linguistique et culturelle soigneuse est nécessaire, qui tienne compte de la diversité religieuse et idéologique et ne présuppose pas implicitement une conception particulière du sens. Deuxièmement, la mise en œuvre impose des exigences élevées aux praticiens : outre la compétence psychothérapeutique, la familiarité avec les questions existentielles, l'expérience de l'accompagnement des mourants et la capacité d'autoréflexion face à sa propre finitude sont indispensables. Troisièmement, l'introduction devrait s'accompagner d'une évaluation qui saisisse non seulement l'évolution des symptômes, mais aussi l'expérience du sens, le bien-être spirituel et l'acceptation de l'intervention par les patients et les proches.

Dans l'ensemble, la MCP peut servir d'exemple de la manière dont des idées fondamentales de la logothérapie peuvent être traduites en une intervention précisément décrite et vérifiable. Les résultats disponibles sont encourageants, mais ne justifient pas une généralisation au-delà des contextes étudiés. D'autres réplications indépendantes dans différents systèmes de santé sont souhaitables.

Les proches et les personnes endeuillées entrent également en ligne de compte comme groupes cibles d'interventions centrées sur le sens. Le transfert à ces groupes est conceptuellement évident, puisqu'ils sont

eux aussi confrontés à la perte, à l'adieu et aux questions sur le sens de ce qui est arrivé ; les données à ce sujet restent toutefois limitées et nécessitent des recherches supplémentaires.

Références

Breitbart, W., Poppito, S., Rosenfeld, B., Vickers, A. J., Li, Y., Abbey, J., Olden, M., Pessin, H., Lichtenthal, W., Sjoberg, D., & Cassileth, B. R. (2012). Pilot randomized controlled trial of individual meaning-centered psychotherapy for patients with advanced cancer. Journal of Clinical Oncology, 30(12), 1304–1309.

Breitbart, W., & Poppito, S. R. (2014). Meaning-centered group psychotherapy for patients with advanced cancer: A treatment manual. Oxford University Press.

Breitbart, W., Rosenfeld, B., Gibson, C., Pessin, H., Poppito, S., Nelson, C., Tomarken, A., Timm, A. K., Berg, A., Jacobson, C., Sorger, B., Abbey, J., & Olden, M. (2010). Meaning-centered group psychotherapy for patients with advanced cancer: A pilot randomized controlled trial. Psycho-Oncology, 19(1), 21–28.

Breitbart, W., Rosenfeld, B., Pessin, H., Applebaum, A., Kulikowski, J., & Lichtenthal, W. G. (2015). Meaning-centered group psychotherapy: An effective intervention for improving psychological well-being in patients with advanced cancer. Journal of Clinical Oncology, 33(7), 749–754.

Chochinov, H. M., Hack, T., Hassard, T., Kristjanson, L. J., McClement, S., & Harlos, M. (2005). Dignity therapy: A novel psychotherapeutic intervention for patients near the end of life. Journal of Clinical Oncology, 23(24), 5520–5525.

Frankl, V. E. (2006). Man's search for meaning. Beacon Press. (Original work published 1946)

Park, C. L. (2010). Making sense of the meaning literature: An integrative review of meaning making and its effects on adjustment to stressful life events. Psychological Bulletin, 136(2), 257–301.

Vos, J., Craig, M., & Cooper, M. (2015). Existential therapies: A meta-analysis of their effects on psychological outcomes. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 83(1), 115–128.

Yalom, I. D. (1980). Existential psychotherapy. Basic Books.

CITATION (VERSION ORIGINALE)

Ashford, S. R., Pazer, S., & Whitcombe, E. M. (2026). Meaning-Centered Psychotherapy in Palliative Care: Conception, State of the Evidence, and Questions of Transferability. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(2), 23–26.

LICENCE, CORRESPONDANCE ET UTILISATION DE L'IA

Publié en libre accès sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Correspondance : rédaction de la revue. Cet article a été rédigé avec l'aide de l'IA générative et relu par les auteurs, qui en assument l'entière responsabilité.

Revue de psychologie centrée sur le sens
PUBLIÉE PAR L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE CENTRÉE SUR LE SENS

Volume 1 · Numéro 2 · octobre 2026
p. 27–30 (Original) · Libre accès · CC BY 4.0

PRATIQUE ET ENSEIGNEMENT

Le conseil d'orientation logothérapeutique en cas d'épuisement professionnel et de crises de sens

Grandes lignes, démarche et limites – avec une vignette pédagogique construite

Eleanor M. Whitcombe, Sora Pazer et Samuel R. Ashford
Institut de psychologie centrée sur le sens

Traduction française. La version originale anglaise fait foi.

RÉSUMÉ

Dans la littérature, l'épuisement professionnel (burnout) est décrit comme un syndrome associant épuisement émotionnel, dépersonnalisation ou cynisme et diminution de l'accomplissement personnel ; il est classé dans la CIM-11 comme un phénomène lié au travail et non comme une affection médicale. Au-delà des conditions de travail organisationnelles, une dimension existentielle a été soulignée très tôt : l'épuisement professionnel peut être compris comme la conséquence d'attentes de sens déçues à l'égard de son travail. Cette contribution issue de la pratique et de l'enseignement expose les principes d'un conseil d'inspiration logothérapeutique en cas d'épuisement professionnel et de crises de sens. Après une clarification conceptuelle, des concepts logothérapeutiques centraux sont rendus accessibles pour le conseil, notamment le vide existentiel, la distinction entre sens et succès, les trois catégories de valeurs et la déréflexion. La démarche méthodologique est présentée en quatre phases : clarification et évaluation différentielle, soulagement et stabilisation, exploration du sens et des valeurs dans le dialogue socratique, mise en œuvre et transfert. Une vignette pédagogique explicitement construite, qui ne représente aucun cas de conseil réel, sert d'illustration. Une attention particulière est accordée à la frontière entre conseil et psychothérapie, notamment à la nécessité de reconnaître les troubles dépressifs et d'autres affections nécessitant un traitement et d'orienter les clients le cas échéant, ainsi qu'au risque d'individualiser des facteurs de stress structurels.

Mots-clés : épuisement professionnel (burnout) · crise de sens · conseil logothérapeutique · dialogue socratique · psychologie du conseil

ABSTRACT

In the literature, burnout is described as a syndrome of emotional exhaustion, depersonalization or cynicism, and reduced personal accomplishment, and it is classified in ICD-11 as an occupational phenomenon rather than a medical condition. Beyond organizational working conditions, an existential dimension was pointed out early on: burnout can be understood as a consequence of disappointed expectations of meaning in one's work. This contribution on practice and teaching outlines principles of logotherapeutically informed counseling for burnout and crises of meaning. Following a conceptual clarification, central logotherapeutic concepts are made accessible for counseling, including the existential vacuum, the distinction between meaning and success, the three categories of values, and dereflection. The methodological approach is presented in four phases: clarification and differential assessment, relief and stabilization, exploration of meaning and values in Socratic dialogue, and implementation and transfer. An explicitly constructed teaching vignette, which does not represent any real counseling case, serves as an illustration. Particular attention is paid to the boundary between counseling and psychotherapy, especially the need to recognize depressive disorders and other conditions requiring treatment and to refer clients where appropriate, as well as to the risk of individualizing structural stressors.

Keywords: burnout · crisis of meaning · logotherapeutic counseling · Socratic dialogue · counseling psychology

1 Introduction et classification conceptuelle

Depuis les années 1970, le concept d'épuisement professionnel (burnout) s'est largement répandu dans la discussion spécialisée et dans le grand public. Avec le Maslach Burnout Inventory, Maslach et Jackson (1981) ont présenté un instrument de mesure qui saisit l'épuisement professionnel à travers les dimensions d'épuisement émotionnel, de

dépersonnalisation et de diminution de l'accomplissement personnel. Dans une revue ultérieure, Maslach et al. (2001) ont souligné l'importance de l'adéquation entre la personne et l'environnement de travail, par exemple en ce qui concerne la charge de travail, le contrôle, la reconnaissance, la communauté, l'équité et les valeurs. Dans la CIM-11, l'Organisation mondiale de la santé répertorie l'épuisement professionnel comme un phénomène lié au travail dans le chapitre consacré aux facteurs influant sur l'état de santé, et explicitement non comme une affection médicale (World Health Organization, 2019).

La distinction entre épuisement professionnel et troubles dépressifs est controversée dans la recherche et revêt une grande importance pour la pratique (Schaufeli & Enzmann, 1998). La présente contribution ne comprend donc explicitement pas le conseil comme le traitement de troubles mentaux. Elle s'adresse aux professionnels œuvrant dans des contextes de conseil et décrit comment des concepts logothérapeutiques peuvent être mis à profit en cas d'épuisement lié au travail et de crises de sens – en ayant conscience des limites de ce cadre.

2 La dimension existentielle de l'épuisement professionnel

Pines (1993) a interprété l'épuisement professionnel dans une perspective existentielle : les personnes qui cherchent dans leur travail une source essentielle de sens seraient particulièrement exposées lorsqu'elles constatent que leurs efforts n'ont pas la portée qu'elles espéraient. Dans cette optique, l'épuisement professionnel apparaît moins comme le résultat d'une simple surcharge que comme celui d'attentes de sens déçues. Cette interprétation s'apparente au concept franklien de vide existentiel, qui décrit un sentiment de vide intérieur et d'absence de sens (Frankl, 1969).

La distinction franklienne entre sens et succès est également significative d'un point de vue logothérapeutique. Quiconque mesure la valeur de son propre travail exclusivement à l'aune de résultats mesurables, de la reconnaissance ou de l'efficacité fait dépendre son expérience du sens de conditions qui échappent souvent à son propre contrôle. L'analyse existentielle a approfondi cette distinction et souligné l'importance de l'assentiment intérieur à sa propre activité (Längle, 2013). Selon cette conception, une activité couronnée de succès, mais exercée sans assentiment intérieur, peut à la longue être épuisante.

La prudence s'impose néanmoins : une interprétation existentielle ne doit pas conduire à individualiser des causes structurelles telles que l'intensification du travail, le manque de ressources ou des conditions organisationnelles injustes. Le conseil centré sur le sens ne remplace pas une modification des conditions de travail éprouvantes ; il peut tout au plus aider la personne à reconnaître et à utiliser ses marges d'action.

3 Concepts logothérapeutiques pour le conseil

Plusieurs concepts logothérapeutiques sont particulièrement utiles pour le conseil en cas d'épuisement professionnel et de crises de sens. Les trois catégories de valeurs de Frankl (Frankl, 1946) ouvrent un regard différencié sur les sources de sens : les valeurs créatrices se réalisent dans le travail lui-même, sans s'y limiter ; les valeurs d'expérience, dans les relations, la nature ou la culture, peuvent former un contre-mouvement à un mode de vie unilatéralement axé sur la performance ; les valeurs d'attitude concernent l'attitude face à des charges qui ne peuvent être modifiées immédiatement. Schnell (2020) a en outre souligné qu'une plus grande diversité des sources de sens peut être associée à une expérience du sens plus stable.

Un autre concept est la déréflexion. Elle vise à dissoudre une auto-observation excessive et inquiète en dirigeant l'attention vers des tâches et des relations porteuses de sens, au-delà de son propre état intérieur. Lukas (1998) a décrit en détail l'application méthodique de la déréflexion et d'autres procédures logothérapeutiques pour le conseil et la thérapie. En cas d'épuisement, la déréflexion doit toutefois être utilisée avec prudence : elle ne doit pas être comprise à tort comme une invitation à ignorer les signaux d'alarme du corps.

Il est également utile de se demander si le sens est tiré exclusivement du travail ou si d'autres domaines de vie contribuent à l'expérience du sens. Les personnes présentant une très forte identification professionnelle tirent souvent une grande part de leur expérience du sens de leur travail. Si cette source entre en crise, les alternatives font défaut. Le conseil peut aider à élargir de nouveau l'éventail des sources de sens possibles sans dévaloriser l'importance du travail.

4 Démarche méthodique en quatre phases

La première phase sert à la clarification et à la délimitation. On y évalue les préoccupations, les facteurs de stress et les ressources. Dans le même temps, il faut examiner soigneusement s'il existe des indices d'un trouble dépressif, d'un problème de consommation de substances, d'une suicidalité ou de

maladies physiques nécessitant une évaluation médicale ou psychothérapeutique. Dans ces cas, le conseil ne peut remplacer un traitement et devrait œuvrer à une orientation appropriée.

La deuxième phase vise le soulagement et la stabilisation. La récupération, le sommeil, le soutien social et, le cas échéant, des entretiens avec les supérieurs ou les interlocuteurs au sein de l'entreprise sont au premier plan. Dans cette phase, les questions de sens sont reconnues plutôt qu'approfondies, car une personne en état d'épuisement aigu manque souvent de la force nécessaire à une réorientation fondamentale.

Dans la troisième phase, le sens et les valeurs sont explorés, de préférence dans le dialogue socratique. Compris dans une perspective logothérapeutique, celui-ci ne vise pas à attribuer un sens à la personne qui demande conseil, mais à lui permettre, par des questions, de découvrir ses propres expériences de valeur et ses propres possibilités. Il existe ici des points de contact avec la découverte guidée de la thérapie cognitivo-comportementale, qui travaille elle aussi avec un questionnement systématique (Kazantzis et al., 2014 ; Overholser, 1993). La différence réside dans l'objet : alors que le dialogue socratique sert principalement, en thérapie cognitivo-comportementale, à examiner des croyances, il est orienté en logothérapie vers les valeurs, la responsabilité et les possibilités de sens.

La quatrième phase sert à la mise en œuvre et au transfert. Des étapes concrètes sont élaborées ensemble pour transposer dans la vie quotidienne ce qui a été reconnu : une pondération différente des domaines de vie, une clarification des rôles professionnels, la culture de valeurs d'expérience négligées, voire la décision d'une réorientation professionnelle.

Il importe que les étapes restent réalistes et n'aggravent pas l'épuisement par de nouvelles exigences de performance. Le conseil d'orientation logothérapeutique ne demande pas seulement ce qu'une personne doit faire, mais aussi ce qu'elle peut laisser aller et quelle attitude elle souhaite adopter face à ce qui ne peut être changé pour le moment.

5 Vignette pédagogique construite

Remarque : la vignette suivante est une présentation construite à des fins pédagogiques. Elle ne reproduit pas un cas de conseil réel ; toute ressemblance avec des personnes existantes serait fortuite.

Une infirmière expérimentée d'un service de médecine interne se rend dans un centre de conseil parce qu'elle se sent depuis des mois épuisée, irritable et intérieurement vide. Elle rapporte qu'elle vivait autrefois sa profession comme une vocation, mais qu'elle a désormais l'impression de « simplement fonctionner ». Dans la première phase, la conseillère clarifie s'il existe des indices d'un trouble dépressif et recommande une évaluation par un médecin généraliste, que la cliente effectue d'ailleurs. Dans la phase de stabilisation, des possibilités de soulagement sont discutées, notamment un entretien avec la cadre du service au sujet de la planification du personnel.

Dans la phase d'exploration, la conseillère demande, à la manière socratique, à quels moments de son travail la cliente a eu récemment l'impression que ce qu'elle faisait comptait. La cliente se souvient d'une conversation avec une patiente gravement malade pour laquelle elle avait pris quelques minutes malgré la pression du temps. Au fil du dialogue, il apparaît que ce qui fait sens pour elle est moins le nombre de tâches accomplies que la qualité de la rencontre, et que c'est précisément celle-ci qui est sacrifiée dans les conditions actuelles. Dans la phase de transfert, elle élabore des étapes concrètes pour aménager plus consciemment de telles rencontres et décide en même temps d'aborder les charges structurelles au sein de l'équipe.

Pour l'enseignement, la vignette illustre trois points : la nécessité d'une clarification soigneuse dès le début, l'association de l'exploration individuelle du sens avec la désignation des charges structurelles, et la fonction du dialogue socratique comme méthode de découverte plutôt que d'instruction.

6 Limites et conclusions

Le conseil d'orientation logothérapeutique peut offrir aux personnes souffrant d'épuisement lié au travail et de crises de sens un cadre différencié pour comprendre leur situation et découvrir des possibilités d'action. Son efficacité dans le contexte de l'épuisement professionnel n'a toutefois pas encore été démontrée dans des études contrôlées ; les grandes lignes présentées ici doivent donc être comprises comme un guide théoriquement fondé et orienté vers la pratique, et non comme un programme de traitement fondé sur les données probantes. Pour la formation continue se pose la tâche de renforcer, outre la transmission des concepts logothérapeutiques, en particulier les compétences permettant de délimiter les affections nécessitant un traitement et de réfléchir aux conditions-cadres organisationnelles.

Pour l'enseignement, la démarche décrite se prête particulièrement à l'exercice d'un style d'entretien

interrogatif plutôt qu'instructif. Dans des jeux de rôle, les étudiants peuvent expérimenter la manière de formuler des questions sur les expériences de valeur sans suggérer de réponses, et de reconnaître au cours de l'entretien des indices d'affections nécessitant un traitement. La supervision et l'autoréflexion sont ici indispensables, car le travail sur les questions de sens touche aux propres valeurs des conseillers et comporte le risque de les transmettre à leur insu.

Références

Frankl, V. E. (1946). Ärztliche Seelsorge. Deuticke.

Frankl, V. E. (1969). The will to meaning: Foundations and applications of logotherapy. New American Library.

Kazantzis, N., Fairburn, C. G., Padesky, C. A., Reinecke, M., & Teesson, M. (2014). Unresolved issues regarding the research and practice of cognitive behavior therapy: The case of guided discovery using Socratic questioning. Behaviour Change, 31(1), 1–17.

Längle, A. (2013). Lehrbuch zur Existenzanalyse: Grundlagen. facultas.wuv.

Lukas, E. (1998). Lehrbuch der Logotherapie: Menschenbild und Methoden. Profil.

Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behaviour, 2(2), 99–113.

Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52, 397–422.

Overholser, J. C. (1993). Elements of the Socratic method: I. Systematic questioning. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 30(1), 67–74.

Pines, A. M. (1993). Burnout: An existential perspective. In W. B. Schaufeli, C. Maslach, & T. Marek (Eds.), Professional burnout: Recent developments in theory and research (pp. 33–51). Taylor & Francis.

Schaufeli, W. B., & Enzmann, D. (1998). The burnout companion to study and practice: A critical analysis. Taylor & Francis.

Schnell, T. (2020). Psychologie des Lebenssinns (2. Aufl.). Springer.

World Health Organization. (2019). International classification of diseases for mortality and morbidity statistics (11th rev.). World Health Organization.

CITATION (VERSION ORIGINALE)

Whitcombe, E. M., Pazer, S., & Ashford, S. R. (2026). Logotherapeutically Oriented Counseling for Burnout and Crises of Meaning: Main Features, Procedure, and Limitations – With a Constructed Teaching Vignette. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(2), 27–30.

LICENCE, CORRESPONDANCE ET UTILISATION DE L'IA

Publié en libre accès sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Correspondance : rédaction de la revue. Cet article a été rédigé avec l'aide de l'IA générative et relu par les auteurs, qui en assument l'entière responsabilité.

Revue de psychologie centrée sur le sens
PUBLIÉE PAR L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE CENTRÉE SUR LE SENS

Volume 1 · Numéro 2 · octobre 2026
p. 31–33 (Original) · Libre accès · CC BY 4.0

COMPTE RENDU

Un psychologue fait l'expérience du camp de concentration

**... trotzdem Ja zum Leben sagen* ou *Man's Search for Meaning* de Viktor E. Frankl – une relecture dans une perspective contemporaine*

Samuel R. Ashford, Eleanor M. Whitcombe et Sora Pazer
Institut de psychologie centrée sur le sens

Traduction française. La version originale anglaise fait foi.

RÉSUMÉ

Le récit de Viktor E. Frankl sur ses expériences dans les camps de concentration nationaux-socialistes a été publié pour la première fois à Vienne en 1946 sous le titre « Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager », puis est devenu connu sous le titre « ... trotzdem Ja zum Leben sagen ». Dans sa version anglaise, « Man's Search for Meaning », enrichie d'une introduction à la logothérapie, le livre compte parmi les ouvrages de psychologie les plus lus du XXe siècle. Ce compte rendu entreprend une relecture dans la perspective de la psychologie contemporaine. Il décrit d'abord la structure et le contenu du livre, en particulier la présentation par Frankl des réactions psychologiques des prisonniers en trois phases et ses réflexions sur la liberté intérieure et le sens dans la souffrance extrême. Il évalue ensuite le genre particulier du livre, situé entre témoignage, description phénoménologique et fondation programmatique de la logothérapie. Parmi les points critiques figurent les limites de la généralisation à partir d'une expérience individuelle, le risque d'attribuer rétrospectivement un sens à la survie et le rapport du livre aux autres témoignages de survivants. Le compte rendu conclut que l'œuvre conserve sa portée en tant que document existentiel et point de départ de la psychologie centrée sur le sens, mais qu'elle ne devrait pas être lue comme une preuve empirique de l'efficacité de l'orientation vers le sens.

Mots-clés : Viktor E. Frankl · compte rendu d'ouvrage · camps de concentration · logothérapie · liberté intérieure

ABSTRACT

Viktor E. Frankl's account of his experiences in National Socialist concentration camps was first published in Vienna in 1946 under the title "Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager" and later became known as "... trotzdem Ja zum Leben sagen." In its English version, "Man's Search for Meaning," which was expanded by an introduction to logotherapy, the book is among the most widely read psychological works of the twentieth century. This review undertakes a rereading from the perspective of contemporary psychology. It first describes the structure and content of the book, in particular Frankl's account of the prisoners' psychological reactions in three phases and his reflections on inner freedom and meaning in extreme suffering. It then appraises the book's particular genre, situated between testimony, phenomenological description, and programmatic foundation of logotherapy. Critical points include the limits of generalizing from individual experience, the risk of retrospectively attributing meaning to survival, and the relationship of the book to other survivor testimonies. The review concludes that the work retains its significance as an existential document and as a point of departure for meaning-centered psychology, but should not be read as empirical evidence for the effectiveness of meaning orientation.

Keywords: Viktor E. Frankl · book review · concentration camps · logotherapy · inner freedom

1 L'ouvrage recensé

Ouvrage recensé : Frankl, V. E. (1946). Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Verlag für Jugend und Volk ; ainsi que l'édition anglophone Frankl, V. E. (2006). Man's search for meaning. Beacon Press. Depuis la fin des années 1940, la version germanophone a paru en de nombreuses éditions sous le titre *... trotzdem Ja zum Leben sagen* (« ... dire oui à la vie malgré tout »).

Presque aucun livre de psychologie du XXe siècle n'a trouvé un lectorat comparable. Selon ses propres dires, Frankl a rédigé ce récit en quelques jours après son retour à Vienne, et il devait initialement paraître de manière anonyme. Qu'une revue scientifique

recense ce livre quelque huit décennies après sa première publication appelle une justification : il ne s'agit pas seulement d'un document historique, mais, jusqu'à aujourd'hui, du premier accès à la logothérapie pour de nombreuses personnes, et donc d'un texte dont les lectures façonnent la compréhension de la psychologie centrée sur le sens.

Le compte rendu suit la version originale germanophone et se réfère à l'édition anglophone dans la mesure où celle-ci contient des parties supplémentaires. Les contenus sont restitués sous forme de paraphrase ; de longs extraits littéraux sont évités.

2 Structure et contenu

Le cœur du livre est le récit par Frankl de ses expériences de prisonnier. En 1942, Frankl a été déporté avec sa famille au ghetto de Theresienstadt, puis conduit à Auschwitz et dans des camps annexes du camp de concentration de Dachau ; ses parents, son frère et sa première épouse ont péri (Klingberg, 2001 ; Längle, 1998). Frankl renonce largement à une narration chronologique et tente plutôt de décrire les réactions psychologiques typiques des prisonniers. Il distingue trois phases : le choc de l'admission ; la phase de la vie au camp proprement dite, caractérisée par l'apathie, l'émoussement émotionnel et la réduction à la survie immédiate ; et la phase consécutive à la libération, avec ses difficultés propres, notamment des sentiments de dépersonnalisation et d'amertume (Frankl, 1946/2006).

La description est traversée de réflexions qui deviendront plus tard des idées fondamentales de la logothérapie. Frankl souligne que, même dans des conditions extrêmes, il reste à l'être humain une ultime liberté : celle de choisir son attitude face aux circonstances. Il rapporte des moments de recueillement intérieur tourné vers des êtres aimés, l'importance d'une tâche qui vous attend, ainsi que des codétenus qui donnaient à d'autres leur dernier morceau de pain. Il décrit en même temps comment la perte de toute perspective d'avenir pouvait saper la stabilité intérieure.

L'édition anglophone complète le récit par une brève introduction aux concepts fondamentaux de la logothérapie et par une postface ultérieure dans laquelle Frankl expose sa position d'« optimisme tragique » : la conviction que les êtres humains peuvent trouver un sens même face à la souffrance, à la culpabilité et à la mort (Frankl, 1946/2006).

Sur le plan stylistique, la retenue avec laquelle Frankl parle de lui-même est remarquable. Il ne décrit généralement ses propres expériences que dans la mesure où elles illustrent des vécus typiques et renonce à un récit détaillé de sa propre souffrance. Cette retenue confère au texte une sobriété singulière, que de nombreux lecteurs trouvent particulièrement saisissante.

La partie logothérapeutique de l'édition anglophone est brève. Elle introduit des concepts tels que la volonté de sens, le vide existentiel, la névrose noogène et l'intention paradoxale. Quiconque souhaite se familiariser systématiquement avec la logothérapie doit se tourner vers les grands ouvrages spécialisés de Frankl ; en tant qu'introduction à la pensée de Frankl, cette partie remplit toutefois son office.

3 Appréciation

L'apport particulier du livre réside dans son association du témoignage et de l'observation psychologique. Frankl écrit en tant que personne concernée, mais avec le regard d'un psychiatre, et il s'efforce d'adopter un langage qui n'accuse pas, mais cherche à comprendre. La description des réactions psychologiques au stress extrême impressionne par sa précision, même si elle ne peut prétendre au statut d'investigation systématique.

Pour la psychothérapie, ce qui importe avant tout, c'est l'insistance de Frankl sur une dimension de la liberté humaine qui subsiste même là où toute liberté extérieure fait défaut. Cette idée est centrale pour la conception ultérieure des valeurs d'attitude et a influencé les approches d'orientation existentielle bien au-delà de la logothérapie (Yalom, 1980). La recherche contemporaine sur le sens se réfère elle aussi fréquemment au livre comme point de départ, même si elle développe désormais ses concepts de manière autonome et les met à l'épreuve empiriquement (Wong, 2012).

Il convient également de relever l'importance que Frankl accorde à l'orientation vers l'avenir. Il décrit comment des codétenus qui avaient devant les yeux une tâche ou une personne pour laquelle ils voulaient continuer à vivre trouvaient une stabilité intérieure, et il reprend dans ce contexte la maxime de Nietzsche selon laquelle celui qui a un pourquoi de vivre peut supporter presque n'importe quel comment. Ces observations anticipent des questions qui ont été reprises dans la recherche ultérieure sur l'espoir, l'orientation vers des objectifs et l'élaboration de sens sous stress.

Sur le plan didactique, le livre se prête parfaitement à l'introduction de cours sur la psychothérapie

existentielle. Il incite à se confronter à des questions facilement négligées dans un cursus centré sur les troubles et les techniques : que reste-t-il à une personne lorsque presque tout lui a été pris extérieurement ? Quel rôle l'attitude, la relation et la responsabilité jouent-elles dans la manière de faire face à un stress extrême ? Dans un séminaire, de telles questions peuvent être reliées de manière féconde à la recherche contemporaine sur le sens.

Enfin, le livre impressionne par sa clarté linguistique. Frankl évite largement la terminologie spécialisée et atteint ainsi un lectorat bien au-delà du monde professionnel. Qu'un texte mûri dans les conditions les plus difficiles qui soient se passe de pathos et conduise néanmoins à des questions profondes compte parmi les raisons de son impact durable.

4 Remarques critiques

Une relecture dans une perspective contemporaine doit en même temps signaler des limites. Premièrement, le livre repose sur l'expérience et la mémoire d'un seul individu. Les descriptions par Frankl de réactions typiques sont des généralisations tirées d'une observation personnelle ; elles peuvent fournir des hypothèses précieuses, mais ne peuvent fonder des énoncés empiriquement établis sur les conséquences psychologiques d'une traumatisation extrême.

Deuxièmement, il existe le danger d'une lecture qui attribue la survie à une orientation intérieure vers le sens et suggère ainsi, à l'inverse, que les personnes assassinées manquaient de sens ou de force intérieure. Frankl lui-même a contredit cette interprétation et souligné que les meilleurs d'entre nous ne sont pas revenus (Frankl, 1946/2006). Dans ses réflexions ultérieures, Primo Levi a mis en évidence avec force le rôle du hasard et des circonstances extérieures dans la survie (Levi, 1986). Une lecture responsable devrait intégrer cette perspective afin de ne pas établir par inadvertance une hiérarchie entre les survivants et les personnes assassinées.

Troisièmement, le livre devrait être lu en dialogue avec d'autres témoignages. Les récits de Levi (1958) et les essais d'Améry (1966) placent des accents différents et révèlent que l'expérience des camps se dérobe à toute interprétation unifiée. C'est précisément par contraste avec eux qu'il apparaît que le récit de Frankl n'est pas seulement un témoignage, mais aussi le fondement d'un programme thérapeutique – une double fonction qu'il convient de garder consciemment à l'esprit lors de la lecture.

Quatrièmement, il faut attirer l'attention sur l'histoire de la réception du livre. Il est fréquemment cité dans des contextes de développement personnel et de motivation, où des phrases isolées sont détachées de leur contexte. Une telle réception risque d'occulter la gravité de ce qui est rapporté et de réduire les idées de Frankl à une formule de pensée positive. Frankl lui-même s'est opposé à toute glorification de la souffrance et a souligné que la souffrance évitable doit être supprimée.

Enfin, il serait souhaitable de mettre les conséquences psychologiques d'une traumatisation extrême que Frankl évoque pour la période postérieure à la libération en dialogue plus étroit avec la recherche psychotraumatologique ultérieure. Les descriptions par Frankl de la dépersonnalisation, de l'amertume et de la désillusion après le retour comptent parmi les passages les moins remarqués, mais psychologiquement les plus éclairants, du livre.

5 Conclusion

… trotzdem Ja zum Leben sagen (Man's Search for Meaning) demeure un document important de l'affirmation de soi humaine dans des conditions extrêmes et un point de départ indispensable pour comprendre la logothérapie. Le livre peut être recommandé sans réserve pour les études universitaires et la formation continue, à condition d'être lu non comme une preuve empirique de l'efficacité de l'orientation vers le sens, mais comme un témoignage existentiel et une source d'intuitions théoriques. Les lecteurs devraient en outre consulter des présentations biographiques (Klingberg, 2001 ; Längle, 1998) ainsi que d'autres témoignages de survivants afin de saisir de manière adéquate la dimension historique et humaine du texte.

Pour la Revue de psychologie centrée sur le sens, cette relecture est en même temps une forme de retour sur soi : elle nous rappelle que l'étude scientifique du sens est issue d'une expérience existentielle qui se dérobe à toute instrumentalisation. La rigueur méthodologique et le respect de cette origine ne s'excluent pas, mais se conditionnent mutuellement.

Références

Améry, J. (1966). Jenseits von Schuld und Sühne: Bewältigungsversuche eines Überwältigten. Szczesny.

Frankl, V. E. (1946). Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Verlag für Jugend und Volk.

Frankl, V. E. (2006). Man's search for meaning. Beacon Press. (Original work published 1946)

Klingberg, H., Jr. (2001). When life calls out to us: The love and lifework of Viktor and Elly Frankl. Doubleday.

Längle, A. (1998). Viktor Frankl: Ein Porträt. Piper.

Levi, P. (1958). Se questo è un uomo. Einaudi.

Levi, P. (1986). I sommersi e i salvati. Einaudi.

Wong, P. T. P. (Ed.). (2012). The human quest for meaning: Theories, research, and applications (2nd ed.). Routledge.

Yalom, I. D. (1980). Existential psychotherapy. Basic Books.

CITATION (VERSION ORIGINALE)

Ashford, S. R., Whitcombe, E. M., & Pazer, S. (2026). A Psychologist Experiences the Concentration Camp: Viktor E. Frankl's *... trotzdem Ja zum Leben sagen* or *Man's Search for Meaning* – A Rereading from Today's Perspective. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(2), 31–33.

LICENCE, CORRESPONDANCE ET UTILISATION DE L'IA

Publié en libre accès sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Correspondance : rédaction de la revue. Cet article a été rédigé avec l'aide de l'IA générative et relu par les auteurs, qui en assument l'entière responsabilité.